Pack stage IFSI (constantes, échelles, transmissions, précautions)

Repères de l'adulte pour le stage : constantes, échelles, transmissions, hygiène et AES

Clairance

Référentiel 2009 (entré.e.s en formation avant septembre 2026) : notions travaillées notamment en UE 2.10 « Infectiologie hygiène », UE 3.1 « Raisonnement et démarche clinique infirmière », UE 4.1 « Soins de confort et de bien-être » et UE 4.3 « Soins d'urgence ».
Repères de l'adulte. Les valeurs, seuils et conduites du protocole de votre service priment.

1 Constantes de l'adulte

Paramètre	Repère	Unité
Fréquence cardiaque (repos)	60 à 100	/min
Pression artérielle (consultation)	HTA si ≥ 140/90 persistante	mmHg
Pression artérielle (automesure)	HTA si ≥ 135/85	mmHg
Pression artérielle basse	PAS < 90 ou PAD < 60, ou en chute	mmHg
Fréquence respiratoire (repos)	12 à 18	/min
SpO_2 (air ambiant)	≥ 95	%
Température	36,5 à 37,3	°C

NOTE CLINIQUE Valeur anormale : consigne de prudence
Valeur très anormale ou patient.e qui va mal : **alerter immédiatement** selon le protocole, puis recontrôler. Valeur anormale isolée chez un.e patient.e stable : recontrôler (matériel, position, repos) et comparer aux valeurs précédentes avant de signaler. En cas de doute, alerter.

PIÈGE
Un chiffre « normal » ne rassure pas seul : la tendance (valeurs successives) et l'aspect du.de la patient.e comptent autant. Une cible prescrite pour ce.tte patient.e (SpO_2 notamment) passe avant le repère du tableau.

2 Échelles de la douleur

Échelle	Cotation et seuil de l'indicateur HAS
EVA	Auto-évaluation. Réglette de 0 à 10 cm (0 à 100 mm). Prise en charge requise si ≥ 4/10 (≥ 40/100).
EN	Auto-évaluation. Note de 0 à 10 donnée par le.la patient.e. Même seuil que l'EVA.
EVS	Auto-évaluation (échelle verbale simple). De 0 (absente) à 4 (extrêmement intense) : absente, faible, modérée, intense, extrêmement intense. Prise en charge requise si ≥ 2.
Algoplus	Hétéro-évaluation, personne âgée qui ne peut pas s'auto-évaluer. Score de 0 à 5. Prise en charge requise si ≥ 2.

Sous ces seuils, la douleur reste évaluée, tracée et prise en compte ; la conduite est celle du protocole du service.

PIÈGE
Choisir **une** échelle et la garder pour suivre l'évolution : un score d'EVA et un score d'EN ne se comparent pas d'une prise à l'autre. Tracer l'échelle utilisée avec le score.

3 Score de Glasgow

Item	Points	Meilleure réponse obtenue
Yeux (Y)	4	Ouverture spontanée
	3	À la demande ou au bruit
	2	À la douleur
	1	Aucune
Verbal (V)	5	Orientée
	4	Confuse
	3	Mots inappropriés
	2	Sons incompréhensibles
	1	Aucune
Moteur (M)	6	Obéit aux ordres
	5	Localise la douleur
	4	Évitement (retrait)
	3	Flexion stéréotypée (décortication)
	2	Extension stéréotypée (décérébration)
	1	Aucune

Score = Y + V + M, de 3 à 15. Noter le détail des trois items, pas seulement le total. Réponse non testable (patient.e intubé.e, paupières œdématiées) : noter NT et la raison, ne pas coter 1.

EXEMPLE Calcul du score
Yeux à la demande (3), réponse confuse (4), localise la douleur (5) : 3 + 4 + 5 = 12, à noter Y3 V4 M5.

NOTE CLINIQUE Baisse du score
Toute baisse par rapport à la cotation précédente s'alerte immédiatement, selon le protocole du service.

4 Risque d'escarre : échelle de Braden

Item	Cotation
Perception sensorielle	1 à 4
Humidité	1 à 4
Activité	1 à 4
Mobilité	1 à 4
Nutrition	1 à 4
Friction et cisaillement	1 à 3

Score total de 6 à 23 : **plus le score est bas, plus le risque est élevé**. Le seuil qui déclenche les mesures de prévention est celui du protocole du service.

5 Transmissions

Transmissions ciblées

- **Cible** : ce qui pose problème ou change (symptôme, réaction, événement), en quelques mots.
- **D, données** : faits observés et mesurés, propos du.de la patient.e.
- **A, actions** : ce qui a été fait, et par qui.
- **R, résultats** : effet observé, réévalué à l'heure dite.

SAED (adaptation française de SBAR, HAS)

- **S, situation** : qui j'appelle, pour quel.le patient.e, motif de l'appel, constantes.
- **A, antécédents** : contexte, traitements, allergies, évolution récente.
- **E, évaluation** : ce que j'en pense, ce qui m'inquiète.
- **D, demande** : ce que j'attends, dans quel délai.

NOTE CLINIQUE Traçabilité
Écrire ce qui est fait, quand il est fait : date, heure, identification de l'auteur.rice. Chaque administration est tracée sur le même support que la prescription. Faits objectifs, sans jugement ; jamais d'acte tracé à l'avance.

6 Précautions standard

Champ (SF2H)
Pour tout soin, en tout lieu, pour tout.e patient.e, quel que soit son statut infectieux.

Les 5 indications de l'hygiène des mains (OMS)

1. Avant de toucher un.e patient.e.
2. Avant un geste aseptique.
3. Après un risque d'exposition à un liquide biologique.
4. Après avoir touché un.e patient.e.
5. Après avoir touché l'environnement du.de la patient.e.

Mesure	Repère
Mains	Friction hydro-alcoolique : technique de référence, gants ou non. Mains visiblement souillées : lavage à l'eau et au savon. *C. difficile*, gale : lavage au savon **puis** friction (friction seule inefficace).
Gants	Si risque de contact avec du sang, un liquide biologique, une muqueuse ou une peau lésée ; pas de gants pour un contact avec une peau saine.
Masque, lunettes	Risque de projection : masque et lunettes, type de masque selon le protocole. Patient.e qui tousse : masque à usage médical, au minimum de type I (norme EN 14683).
Matériel	Matériel de sécurité et à usage unique ; conduite AES connue de tous.

7 Précautions complémentaires

Respiratoires (SF2H 2024)
La SF2H a remplacé en 2024 la distinction Air / Gouttelettes par trois niveaux de précautions complémentaires respiratoires : simples, renforcées, maximales. Le niveau et le type de masque (soignant.e, patient.e) suivent le protocole de l'établissement et l'équipe d'hygiène.

Type	Mesures (en plus des précautions standard)
Contact	Chambre seule ou regroupement, signalée. Tablier pour les soins directs. Hygiène des mains en sortant de la chambre.

⚠ PIÈGE
Les précautions sont prescrites et signalées : suivre la signalétique et le protocole du service, ne pas déduire le niveau du diagnostic supposé.

8 Accident d'exposition au sang (AES)

Premiers soins, tout de suite (INRS)

Piqûre, coupure, peau lésée : ne pas faire saigner ; nettoyer à l'eau et au savon, rincer ; désinfecter au moins 5 min (Dakin, ou eau de Javel à 2,6 % de chlore actif diluée au 1/5e ; à défaut polyvidone iodée en solution dermique ou alcool à 70°).
Projection sur une muqueuse (œil, bouche, nez) : rincer abondamment au moins 5 min au sérum physiologique ou à l'eau.

✚ NOTE CLINIQUE Délais
Sous 1 h : avis médical, selon la procédure AES de l'établissement, pour évaluer le risque infectieux ; un traitement post-exposition, s'il est indiqué, débute idéalement dans les 4 h.
Dans les 24 h : informer sa hiérarchie (en stage : le service et l'IFSI), déclarer l'accident du travail, suivre les recommandations médicales, informer le.la médecin du travail.

⚠ PIÈGE
Ne pas attendre la fin du soin ou du poste pour consulter : le délai compte à partir de l'accident.

Sources : HAS (HTA, douleur IQSS, SAED), MedlinePlus (FC, PA basse), Manuel MSD et CHUV (Glasgow), SF2H (précautions standard, contact, respiratoires 2024), CPias Hauts-de-France, OMS (hygiène des mains), INRS (AES), AP-HP (dossier de soins), HUG (Braden), arrêtés du diplôme d'État d'infirmier ; détail dans les références du produit.